

Kyste Hydatique du poumon

Résidanat – Sujet 36

Wajih Ghribi
Service de Pneumologie
CHU FB Monastir
17/09/2025

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- **Le kyste hydatique du poumon:**
 - A. Est souvent de bon pronostic
 - B. Guérit spontanément
 - C. Se calcifie souvent
 - D. Peut se compliquer
 - E. Est de traitement essentiellement médical

- **Le Kyste hydatique du poumon:**

- A. représente la première localisation chez l'Adulte
- B. Touche surtout les sujets âgés
- C. Est plus fréquent chez les hommes que les femmes
- D. Peut être associé à une localisation extra-pulmonaire
- E. Est toujours associé à une localisation hépatique

- Les facteurs d'hyper-endémicité de l'hydatidose en Tunisie sont:
 - A. L'intensité d'élevage traditionnel en milieu rural tunisien
 - B. La densité du réservoir bovin
 - C. La difficulté de ramassage des carcasses des ruminants décédés
 - D. L'abattage non contrôlé surtout en zone rurale
 - E. Le climat tempéré de la Tunisie

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- *E. granulosus*:

- A. Appartient à la classe des Nématodes
- B. se présente sous trois formes évolutives
- C. Le ver adulte vit dans l'intestin grêle de l'Homme
- D. Sa longévité est de quelques jours
- E. Le premier anneau du corps est germinatif

- *Concernant les œufs d'E. granulosus:*
 - A. Comportent une coque externe embryophore
 - B. Sont de l'ordre de 10 à 20 dans l'anneau germinatif
 - C. Sont résistant dans le milieu extérieur
 - D. Contiennent l'embryon hexacanthé
 - E. Leur longévité est de quelques heures

- Les trois formes évolutives du kyste hydatique sont:

- A. L'embryon hexacanthé

- B. Ver adulte

- C. Le scolex

- D. Les œufs

- E. La forme larvaire ou hydatide

- Concernant le cycle naturel du KH:

- A. Le mouton constitue l'hôte définitif
- B. L'homme est une impasse parasitaire
- C. Le dernier anneau du ténia échinocoque contient les œufs.
- D. L'homme est contaminé par le mouton
- E. Une contamination du personnel du laboratoire est possible

- **La contamination hydatique de l'homme se fait par:**
 - A. Ingestion de légumes souillés par les excréments du chien infesté
 - B. Ingestion de viande de mouton infesté
 - C. Inhalation de tænia échinocoque
 - D. Contact avec des moutons porteurs de kyste hydatique
 - E. Contact par les mains avec le chien parasité

■ **La contamination hydatique de l'homme:**

- A. A lieu généralement dans l'enfance
- B. Est toujours par voie orale
- C. Peut être due à l'ingestion d'une eau contaminée par les déjections de chiens Contact avec des moutons porteurs de kyste hydatique
- D. Passe par la traversée active des embryons hexacanthés par la paroi intestinale
- E. Est due à l'ingestion du ver adulte d' *E. granulosus*

- Les embryons hexacanthés rejoignent la circulation systémique essentiellement par:

- A. La voie lymphatique
- B. La voie cave
- C. La voie portale
- D. Voie bronchogénique
- E. inhalation

- Au niveau pulmonaire, la greffe parasitaire
 - A. Est souvent primitive
 - B. Est essentiellement hématogène
 - C. N'est jamais bronchogénique
 - D. Peut être suivie par un passage des embryons au delà de ce filtre
 - E. Est souvent associée à une localisation cardiaque droite

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- Les constituants du parasite *E. granulosus* sous sa forme kystique sont:

A. L'adventice

B. La cuticule ou membrane lamellaire

C. La membrane prolifère ou germinative

D. Le liquide hydatique

E. Le sable hydatique

- La membrane prolifère du kyste hydatique est:
 - A. La membrane externe
 - B. Anhiste
 - C. Joue un rôle majeur dans la croissance du kyste
 - D. Donne naissance au liquide hydatique
 - E. Donne naissance aux vésicules prolifères

■ Le liquide hydatique est:

A. Très riche en protoscolex

B. Aseptique

C. Faiblement antigénique

D. Est l'élément responsable des réactions anaphylactiques liées au kyste hydatique

E. À pH acide

- Le sable hydatique comporte:
 - A. Des protoscolex
 - B. Des vésicules proligères
 - C. Des vésicules filles endogènes
 - D. des crochets libres
 - E. Des anneaux

- Un KHP peut évoluer vers:

- A. La compression bronchique

- B. La rupture dans les bronches

- C. La rupture dans un vaisseau

- D. La rupture dans la plèvre

- E. La fistulisation à la paroi

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- **Le KHP simple :**

- A. Est souvent cliniquement silencieux
- B. Est un kyste compliqué
- C. Peut être responsable de dyspnée chez l'enfant
- D. Peut être à l'origine d'une toux sèche
- E. Se traduit par une opacité hétérogène à la radiographie du thorax

- Concernant l'imagerie du kyste hydatique simple:
 - A. Le scanner thoracique est la première exploration à demander.
 - B. L'échographie thoracique est pratiquée en cas de kyste périphérique.
 - C. L'hydatide prend le contraste après injection du produit de contraste au scanner thoracique.
 - D. L'IRM thoracique est souvent indiquée
 - E. Il s'agit souvent d'une opacité ronde à la radiographie thoracique.

- **La fissuration du kyste:**
 - A. Est responsable d'une vomique hydatique
 - B. Est souvent cliniquement silencieuse
 - C. Peut être responsable d'anaphylaxie
 - D. Donne une image dite " Pneumokyste"
 - E. Est responsable d'une ischémie de l'hydatide

- **La rupture du kyste hydatique dans les bronches:**
 - A. Est asymptomatique
 - B. Est responsable de vomique hydatique
 - C. Est à l'origine d'une infection du kyste
 - D. Donne une image en « double arc » à la radiographie
 - E. Peut être responsable d'anaphylaxie

- La vomique hydatique:
 - A. Est un signe pathognomonique du KHP
 - B. Peut être responsable d'un tableau de détresse respiratoire aigue
 - C. Peut entrainer une hémoptysie cataclysmique
 - D. Peut être associée à un choc anaphylactique
 - E. Est toujours fractionnée

- **Les aspects radiographiques d'un KHP rompu dans les bronches sont:**
 - A. Une image en « boulet de canon »
 - B. Image de « pneumokyste »
 - C. Un niveau hydroaérique
 - D. Une image en grelot
 - E. Une cavité isolée

- **En cas de rupture du KHP dans les bronches, la radiographie du thorax peut montrer:**

- A. L'image du double croissant aérique
- B. Une image en « nénuphar »
- C. Une cavité vide
- D. Un aspect normal
- E. Une opacité arrondie

- **La rupture du KHP dans la plèvre:**
 - A. Est une complication fréquente
 - B. Est une complication redoutable
 - C. Peut être responsable d'une détresse respiratoire
 - D. Se traduit par un hydropeumothorax à la radiographie
 - E. Peut poser des difficultés thérapeutiques

- **Le KHP peut se compliquer de:**

- A. Transformation néoplasique

- B. Rupture

- C. Infection

- D. Hémoptysie

- E. Dilatations de bronches

▪ **Le KHP rompu dans la plèvre se manifeste par:**

A. Une douleur thoracique

B. Une vomique hydatique

C. Une dyspnée

D. Une hémoptysie

E. Une toux

- **L'aspect radiologique caractéristique du kyste hydatique fissuré est:**
 - A. L'aspect de « membrane flottante »
 - B. L'image cavitaire
 - C. L'image en grelot
 - D. L'image en « pneumokyste »
 - E. L'opacité bilobée bien limitée

- **Le KHP sain peut se présenter sur la radiographie sous forme d'une:**
 - A. Opacité arrondie bien limitée
 - B. Opacité lobaire systématisée triangulaire
 - C. Image en grelot
 - D. Image avec croissant gazeux
 - E. Image hydroaérique

▪ **La principale circonstance de découverte du KHP sain est:**

A. L'hémoptysie

B. La douleur thoracique

C. La toux sèche

D. La dyspnée d'effort

E. La découverte radiologique systématique

- Le KHP de l'enfant:
 - A. Constitue la deuxième localisation après celle du foie
 - B. Se caractérise par une croissance très rapide
 - C. Reste longtemps asymptomatique
 - D. Peut être responsable de déformation thoracique
 - E. Est souvent de mauvais pronostic

- L'hydatidose pulmonaire multiple:
 - A. Est essentiellement d'origine primitive
 - B. Est la forme la plus fréquente du KHP
 - C. Comporte des KH d'âge différent en cas de dissémination hématogène
 - D. Se caractérise par la difficulté de la prise en charge
 - E. Peut donner l'aspect de lâcher de ballon à la radiographie thoracique

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- Concernant les explorations du KHP:
 - A. L'hyperéosinophilie est constante
 - B. Le diagnostic parasitologique direct est nécessaire au diagnostic positif
 - C. La sensibilité de la sérologie hydatique augmente nettement en cas de kyste compliqué ou d'hydatidose multiple
 - D. Une sérologie hydatique négative élimine le diagnostic de KHP.
 - E. La vitesse de sédimentation est toujours élevée

- Concernant l'imagerie du kyste hydatique du poumon:
 - A. La réalisation d'une échographie abdominale est systématique
 - B. L'échographie thoracique d'un kyste périphérique montre une formation anéchogène avec renforcement des échos postérieurs
 - C. La TDM thoracique est surtout indiquée en cas de kystes multiples, de kyste proximal avec contact médiastinal et de rupture dans la plèvre
 - D. La radiographie thoracique est l'examen fondamental pour faire le diagnostic
 - E. Le PET Scan est nécessaire avant l'acte opératoire

- **La fibroscopie bronchique peut objectiver un aspect de membrane accouchée au niveau d'une bronche dans:**
 - A. Le KHP sain
 - B. Le KHP fissuré
 - C. Le KHP rompu
 - D. Le KHP infecté
 - E. Le KHP ouvert dans la plèvre

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

- Devant une image radiologique en grelot, on évoque:
 - A. Un aspergillome
 - B. Un séquestre caséeux ou pyogène
 - C. Un cancer nécrosé
 - D. Une pneumonie franche lobaire aiguë
 - E. Un kyste hydatique du poumon rompu

- Devant une image hydro-aérique à la radiographie thoracique, on évoque:

A. Abscès

B. Tuberculome

C. Caverne tuberculeuse

D. Cancer nécrose

E. Kyste hydatique du poumon

OBJECTIFS :

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.

■ **Le traitement du KHP :**

- A. Est essentiellement chirurgical
- B. Est médical si le malade est inopérable ou en cas d'exérèse incomplète des lésions
- C. Est facultatif
- D. Permet de prévenir les récurrences
- E. Dépend de l'état du kyste

▪ **Les techniques du traitement chirurgical du KHP dépendent :**

A. Du nombre des kystes

B. De la taille du kyste

C. Du siège du kyste

D. Des tares du patient

E. De l'âge du patient

- Concernant le traitement chirurgical du kyste hydatique du poumon:
 - A. La thoracotomie axillaire constitue la voie d'abord standard
 - B. L'énucléation est indiquée pour les kystes non compliqués
 - C. La kystectomie est indiquée pour les kystes pleins et de taille supérieure à 3cm.
 - D. Le traitement du périkyte dépend de l'état du périkyte et du parenchyme adjacent
 - E. La périkysectomie est contre-indiquée en cas de périkyte infecté

- Le traitement du KHP repose sur:
 - A. La thoracotomie ou VATS en utilisant la technique de Barrett pour le KHP central
 - B. La thoracotomie en utilisant la technique d'Ugon pour les gros kystes
 - C. La périkystectomie totale pour les KHP périphériques
 - D. Le traitement du kyste primitif et la décortication en cas d'ouverture dans la plèvre
 - E. La transplantation en cas de kyste hydatique rompu dans la plèvre

- **Lorsqu'un kyste hydatique du foie est associé à un KHP:**
 - A. On opère le KHF dans un premier temps
 - B. On opère le KHP dans un premier temps
 - C. Il est possible de les opérer en un seul temps s'ils sont contralatéraux
 - D. Il est possible de les opérer en un seul temps s'ils sont homolatéraux
 - E. Il est possible de les aborder par la même voie s'ils sont homolatéraux

- Les complications post-opératoires tardives du KHP comportent:

A. L'hémoptysie

B. Les DDB

C. La greffe aspergillaire

D. La transformation néoplasique

E. La récidence hydatique

1. Décrire les caractéristiques épidémiologiques de l'hydatidose pulmonaire et hépatique en Tunisie et dans le monde.
2. Expliquer le cycle du parasite *Echinococcus granulosus* et les modes d'infestation de l'homme.
3. Décrire l'aspect anatomo-pathologique du kyste hydatique au cours de ses différentes phases évolutives.
4. Décrire les différents tableaux radio-cliniques du kyste hydatique du poumon en fonction de ses stades évolutifs et de ses complications.
5. Planifier les examens complémentaires nécessaires au diagnostic et au bilan d'extension du kyste hydatique du poumon.
6. Discuter les principaux diagnostics différentiels en fonction des stades évolutifs du kyste hydatique du poumon.
7. Décrire le principe et les indications du traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire en fonction de son stade évolutif.
8. Réunir les éléments cliniques et para-cliniques du diagnostic positif du kyste hydatique dans sa localisation hépatique et dans ses différentes formes cliniques.
9. Décrire la segmentation tomodensitométrique du foie.
10. Préciser le rôle de la tomodensitométrie dans l'exploration d'une hydatidose hépatique.
11. Identifier les différents types de kystes hydatiques du foie selon la classification échographique de Gharbi.
12. Décrire les principes du traitement chirurgical du kyste hydatique du foie et ses complications.
13. Décrire les moyens de **prévention** du kyste hydatique.

- La prophylaxie contre le kyste hydatique du poumon comporte:
 - A. Interdiction des abatages non contrôlés
 - B. Traitement les chiens domestiques par les ténifuges
 - C. Eviction du contact entre l'Homme et les moutons infectés.
 - D. Mise à disposition des chiens les viscères des moutons
 - E. Enterrement a plus de 1m de profondeur des viscères parasités

Cas Clinique

Patient A. M âgé de 36 ans, tabagique 5 paquets-années, sans antécédents pathologiques notables, agriculteur, consulte pour toux évoluant depuis 10 jours, douleurs thoraciques droites évoluant depuis 2 semaines et hémoptysie de faible abondance depuis 3 jours. A l'examen clinique: température à 37.9°C, fréquence cardiaque: 86 battements / minute, tension artérielle: 120 / 80 mmHg, auscultation pulmonaire normale, et fréquence respiratoire à 16 cycles / minute. Le reste de l'examen est sans particularités. Radio thorax: image excavée faisant 7 cm de diamètre avec un niveau hydro-aérique au niveau du tiers moyen du champ pulmonaire droit.

1 Cette présentation radio-clinique fait évoquer:

A. Kyste hydatique du poumon rompu

B. Cancer bronchique primitif

C. Abscès du poumon

D. Tuberculose pulmonaire

E. Sarcoidose

2- Les explorations à réaliser chez ce patient dans le cadre de l'enquête étiologique sont:

- A. TDM thoracique
- B. Ponction biopsie transthoracique
- C. Sérologie hydatique
- D. Fibroscopie bronchique
- E. Recherche de BK dans les crachats

3- En cas de confirmation du kyste hydatique du poumon rompu dans les bronches, le traitement consiste à réaliser:

- A. Enucléation et capitonnage
- B. Périkysectomie ou résection réglée
- C. Ponction évacuation de la cavité
- D. Drainage thoracique
- E. Une embolisation artérielle